LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 1 Các thời kỳ tuổi trẻ

Biên soạn lại từ tài liệu Các thời kỳ tuổi trẻ.pdf (9 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa

1. THỜI KỲ BÀO THAI
2. THỜI KỲ SƠ SINH
3. THỜI KỲ NHŨ NHI
4. THỜI KỲ RĂNG SỮA
5. THỜI KỲ THIẾU NHI
6. THỜI KỲ THIẾU NIÊN
7. BẢNG TỔNG HỢP BỆNH LÝ VÀ RĂNG MIỆNG THEO THỜI KỲ

Học xong bài này, bạn cần: kể được tên và khoảng thời gian của 6 thời kỳ tuổi trẻ; nêu được đặc điểm sinh lý, bệnh lý, dịch tễ nổi bật của từng thời kỳ; biết chọn cách chăm sóc, dự phòng và can thiệp nha khoa phù hợp với từng độ tuổi.

Hiểu nhanh: trẻ em **không phải là người lớn thu nhỏ**. Ở mỗi giai đoạn, cơ thể trẻ đang "xây" một thứ khác nhau (cơ quan, não, răng, chiều cao, tuyến sinh dục). Thứ đang xây nhanh nhất cũng là thứ **dễ bị tổn thương nhất**. Nắm được điều này là đoán được bệnh hay gặp và cách phòng ở từng thời kỳ.

Thời kỳ	Thời gian
Bào thai	Trung bình **38 tuần** (280 ± 15 ngày) tính từ lúc thụ tinh
Sơ sinh	**28 ngày đầu** sau sinh
Nhũ nhi	Từ **tháng thứ 2 đến tháng thứ 12**
Răng sữa	Từ **1 đến 6 tuổi** (nhà trẻ 1–3 tuổi, mẫu giáo 4–6 tuổi)
Thiếu nhi	Từ **7 đến 11 tuổi** (tuổi học đường)
Thiếu niên	Từ **12 đến 18 tuổi**, có thể kéo dài đến **20 tuổi**

Mẹo nhớ thứ tự: "Bào – Sơ – Nhũ – Răng – Thiếu nhi – Thiếu niên", tương ứng các mốc **thụ tinh → 28 ngày → 1 tuổi → 6 tuổi → 11 tuổi → 18 tuổi**.

1. THỜI KỲ BÀO THAI

- **Thời gian:** trung bình **38 tuần** (280 ± 15 ngày), tính từ lúc **thụ tinh** đến khi trẻ đủ tháng chào đời.
- Gồm **2 giai đoạn** có đặc tính sinh học rất khác nhau: **phôi** và **thai**.

1.1. Giai đoạn phôi (8 tuần đầu)

- **Sinh lý:**
  - Giai đoạn **tượng hình** các bộ phận: các hệ cơ quan chính hình thành theo một **lịch trình thời gian nghiêm ngặt**.
  - Tế bào tăng chủ yếu về **số lượng** hơn là khối lượng → thai **tăng cân ít nhưng dài ra rất nhanh**.
  - Cuối **tuần 8**: chiều dài đầu – mông khoảng **3 cm**, các hệ cơ quan cơ bản đã thiết lập.
  - **Mầm răng sữa** hình thành rất sớm, ngay trong **3 tháng đầu** thai kỳ.
  - **Mầm xoang cạnh mũi** (như xoang hàm) xuất hiện từ **tuần 8**.
- **Bệnh lý:** cực kỳ nhạy cảm với tác nhân độc hại → **sẩy thai, quái thai, dị tật bẩm sinh**. Yếu tố nguy cơ:

    - **Độc chất:** dioxin, thủy ngân, thalidomide, rượu, khói thuốc lá...
    - **Thuốc:** an thần, kháng sinh, nội tiết tố, chống động kinh, chống ung thư...
    - **Nhiễm siêu vi:** cúm, **rubella**, nhóm **TORCH**...
    - **Tác nhân vật lý:** tia X, chất phóng xạ...
- **Phòng ngừa:** giáo dục tiền hôn nhân; tầm soát dị tật bẩm sinh tiền sản; tránh tuyệt đối nguồn lây và chất độc; **chỉ dùng thuốc theo chỉ định nghiêm ngặt** của bác sĩ.

> **Vì sao 8 tuần đầu nguy hiểm nhất?** Đây là lúc các cơ quan đang được "đúc khuôn". Một tác nhân độc tác động đúng lúc một cơ quan đang hình thành sẽ để lại **dị tật vĩnh viễn** ở cơ quan đó. Điều đáng lo là nhiều bà mẹ **chưa biết mình có thai** trong giai đoạn này, nên giáo dục tiền hôn nhân và dùng thuốc thận trọng ở phụ nữ tuổi sinh đẻ rất quan trọng.

> **Liên hệ nha khoa:** mầm răng sữa đã hình thành từ 3 tháng đầu thai kỳ. Vì vậy sức khỏe, dinh dưỡng và thuốc mẹ dùng lúc mang thai ảnh hưởng trực tiếp đến **chất lượng men răng sữa** của con sau này.

1.2. Giai đoạn thai (tuần 9 đến khi sinh)

- **Sinh lý:** đặc trưng bởi **tăng trưởng và biệt hóa nhanh** các mô, cơ quan.

Mốc	Sự kiện
Tuần 10	Khuôn mặt có các nét cơ bản
Tuần 12	Cơ quan sinh dục ngoài phân biệt rõ giới tính; phổi có **mầm phế quản**
Tuần 20–24	Xuất hiện **phế nang nguyên phát**, bắt đầu tổng hợp **surfactant**
Khoảng tuần 20	Mẹ cảm nhận được **cử động thai**, gắn kết mẹ – con rõ rệt
Tam cá nguyệt 3	Tích lũy mạnh **calcium, sắt, đạm, chất béo**; chiều dài **gấp đôi**, cân nặng **gấp ba** so với cuối tam cá nguyệt 2

- Cân nặng lúc sinh trung bình khoảng **3.000 g** (2.500–3.500 g).
- **Giác quan:** phát triển vị giác, khứu giác, xúc giác; thai biết phản ứng với môi trường (tăng / giảm nhịp tim).
- **Thần kinh:** sau tuần 8 các cấu trúc chính đã thiết lập; synapse hình thành rất nhanh → hệ thần kinh trung ương **rất nhạy cảm với thiếu oxy**.
- **Tâm lý:** dinh dưỡng, thuốc men và tinh thần của mẹ (lo âu, hát ru con) đều tác động trực tiếp lên thai.
- **Bệnh lý:**
    - Mẹ **tăng cân kém** → **suy dinh dưỡng bào thai**.
    - Tam cá nguyệt cuối, **hàng rào nhau thai giảm bảo vệ** → dễ **sinh non, nhiễm trùng** nếu mẹ mắc bệnh.
    - Mẹ **sang chấn tâm lý kéo dài** → rối loạn trục hạ đồi – tuyến yên – thượng thận và thần kinh thực vật của thai → trẻ **nhẹ cân, sinh non, sẩy thai, vòng đầu nhỏ**; tăng nguy cơ **ADHD, ám ảnh cưỡng chế, kém nhận thức** về sau.
- **Phòng ngừa:** khám thai định kỳ, tiêm ngừa đầy đủ, tránh lo âu buồn phiền, dinh dưỡng đầy đủ, tránh nguồn lây bệnh.

> **Vì sao trẻ sinh non dễ suy hô hấp?** Surfactant (chất giữ cho phế nang không xẹp) chỉ **bắt đầu** được tổng hợp từ tuần 20–24 và tăng dần đến cuối thai kỳ. Trẻ ra đời càng sớm thì phổi càng thiếu chất này.

2. THỜI KỲ SƠ SINH

- **Thời gian: 28 ngày đầu** sau sinh.
- **Sinh lý:**
  - Trẻ thực hiện một **"cuộc cách mạng sinh lý"** để thích nghi với môi trường ngoài tử cung: **tự thở, tự tuần hoàn, tự tiêu hóa**...
  - Sau tiếng khóc chào đời, trẻ có **phản xạ đòi bú**.
  - **Sữa non** là thức ăn đầu tiên và lý tưởng nhất: nhiều **đạm**, **globulin miễn dịch (chủ yếu IgA)** chống nhiễm trùng, và nhiều **vitamin A** để dự trữ ở gan.
  - **Tiếp xúc da kề da** ngay sau sinh giúp trẻ **bú mẹ sớm hơn**, bú mẹ **lâu hơn** và gắn kết tình cảm mẹ – con.
- **Bệnh lý:**
  - Dễ tổn thương do các bất thường từ thời kỳ bào thai để lại.
  - **Nguy cơ tử vong cao nhất:** tử vong sơ sinh chiếm **47%** tử vong trẻ dưới 5 tuổi (WHO 2017); **75%** trong số đó xảy ra trong **24 giờ đầu**.
  - **Sang chấn sản khoa / tổn thương chu sinh:** xuất huyết não – màng não, sinh ngạt, gãy xương đòn...
  - **Nhiễm trùng sơ sinh nguy kịch:** nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, viêm phổi...
- **Phòng ngừa:**
  - Sản phụ **tiêm ngừa uốn ván** đầy đủ; **sinh tại cơ sở y tế** đủ trang thiết bị.
  - **Da kề da**, cho bú sữa non **càng sớm càng tốt (trong 60 phút đầu)**.
  - Hướng dẫn mẹ kỹ thuật cho bú; theo dõi sát trẻ sơ sinh nguy cơ cao.

> **Ghi nhớ con số: 47%** tử vong dưới 5 tuổi là tử vong sơ sinh, và **3/4** trong số đó ở **ngày đầu tiên**. Vì thế mọi can thiệp quan trọng nhất đều dồn vào **cuộc đẻ và 24 giờ đầu**: đỡ đẻ an toàn, giữ ấm, da kề da, bú sớm.

3. THỜI KỲ NHŨ NHI

- **Thời gian: tháng thứ 2 đến tháng thứ 12** sau sinh.
- **Sinh lý:** tăng trưởng thể chất và phát triển tâm vận động **mạnh mẽ nhất**; tạo hình và liên kết neuron thần kinh đạt **đỉnh điểm**.

Chỉ số lúc 12 tháng	Thay đổi
Não	Thể tích **gấp đôi**, đạt khoảng **72%** não người lớn
Cân nặng	**Gấp 3** lúc sinh
Chiều dài	Tăng **25 cm**, đạt khoảng **75 cm**
Vòng đầu	Tăng **10 cm**, đạt khoảng **44 cm**

- Lớp **mỡ dưới da** phát triển mạnh → trẻ trông **bụ bẫm, tròn trịa**.

- Nhu cầu năng lượng rất cao: **120–130 kcal/kg/ngày**, **gấp 3 người lớn** → từ **sau 6 tháng**, sữa mẹ đơn thuần **không còn đủ**.
- **Miễn dịch:** thừa hưởng **IgG** từ mẹ qua nhau thai và **IgA** qua sữa mẹ (phòng sởi, thủy đậu, bạch hầu, thương hàn...), nhưng **cạn dần sau 6 tháng**.
- **Mọc răng:**
  - Răng bắt đầu nhú lúc **6 tháng**.
  - Răng đầu tiên thường là **2 răng cửa hàm dưới**.
  - Từ **6–12 tháng** mọc đủ **8 răng cửa** (4 trên, 4 dưới).
  - Ăn dặm phải **đặc dần rồi cứng dần** từ tháng thứ 6 → giúp trẻ **tập nhai**, dùng cơ nhai, kích thích tuyến nước bọt tiết men tiêu hóa.
  - Lúc mọc răng trẻ có thể **sốt nhẹ, ăn kém, quấy khóc, rối loạn giấc ngủ**.
- **Bệnh lý:**
  - Nhu cầu calo cao nhưng tiêu hóa **chưa hoàn chỉnh** → dễ **rối loạn tiêu hóa, suy dinh dưỡng** nếu nuôi ăn sai.
  - Thần kinh **chưa myelin hóa đầy đủ**, hưng phấn và ức chế dễ lan tỏa → sốt cao dễ **sốt co giật**.
  - **"Khoảng trống miễn dịch"** sau 6 tháng → nguy cơ nhiễm trùng **tăng vọt**.
  - Bắt đầu hiếu động → **tai nạn**: ngạt nước, điện giật, ngộ độc do uống nhầm thuốc / hóa chất.
  - **Trầm cảm sau sinh** ở mẹ (có thể kéo dài đến 6 tháng) → trẻ ít chơi đùa, dễ giận dữ, buồn rầu, kém năng động.
- **Phòng ngừa:**
  - **Bú mẹ hoàn toàn 4–6 tháng đầu.**
  - **Ăn dặm đúng cách từ khi tròn 6 tháng**, song song tiếp tục bú mẹ.
  - Tiêm chủng đủ theo lịch; theo dõi phát triển định kỳ; tầm soát và can thiệp sớm **trầm cảm sau sinh** ở mẹ.

> **Hiểu nhanh về "khoảng trống miễn dịch":** kháng thể mẹ cho giống như **"tiền tiết kiệm"** – dùng dần và hết khoảng 6 tháng. Trong khi đó "thu nhập" (kháng thể trẻ tự làm ra) còn ít. Khoảng thiếu hụt này là lý do trẻ **sau 6 tháng** bắt đầu ốm vặt nhiều và vì sao **lịch tiêm chủng** dày đặc trong năm đầu.

> **Lưu ý khi khám:** trẻ mọc răng có thể sốt nhẹ, nhưng **không được quy mọi cơn sốt cao cho "mọc răng"** – phải tìm nguyên nhân nhiễm trùng (xem Bài 7).

4. THỜI KỲ RĂNG SỮA

- **Thời gian: 1–6 tuổi**, chia 2 giai đoạn:
  - **Nhà trẻ (1–3 tuổi):** tập đi; ngôn ngữ và ký hiệu phát triển mạnh từ **18 tháng**, giúp định hình hành vi.
  - **Mẫu giáo (4–6 tuổi):** ngôn ngữ phát triển vượt bậc, tiếp xúc xã hội rộng, tập xa bố mẹ để đi học, hình thành nhân cách và tư duy.
- **Sinh lý:**
  - Tăng trưởng **chậm lại**, trẻ mất dáng mập tròn và trở nên **thon gầy**; mỗi năm tăng khoảng **2.000 g**.
  - **4 tuổi:** chiều cao **gấp đôi lúc sinh** (khoảng **1 m**). **6 tuổi:** não và vòng đầu **gần bằng người lớn**.
  - Vốn từ tăng từ **50–100 từ** lên **hơn 2.000 từ**.
  - Trẻ đã nhai được thức ăn cứng như người lớn; nếu vẫn cho ăn lỏng mềm như thời nhũ nhi sẽ **dễ chán ăn**.

Hoàn thiện hệ răng sữa

- Trẻ mọc đủ **20 răng sữa** trong khoảng **6–30 tháng**:

Tuổi	Răng sữa mọc
6–12 tháng	8 răng cửa
12–18 tháng	4 răng tiền hàm sữa (răng hàm sữa thứ nhất)
18–24 tháng	4 răng nanh sữa
24–30 tháng	4 răng hàm lớn sữa (răng cấm sữa)

Mẹo nhớ: cứ **6 tháng một đợt**, bắt đầu từ tháng 6: **cửa (8) → tiền hàm (4) → nanh (4) → hàm lớn (4)** = **20 răng**. Lưu ý **răng nanh mọc sau răng tiền hàm sữa**.

Thói quen xấu và nguy cơ sâu răng

- **Cai sữa:** nên cai lúc **12–15 tháng**.
- **Không cho bú đêm:** đường trong sữa **đọng lại quanh răng** suốt đêm là nguyên nhân hàng đầu gây **sâu răng lan tỏa**.
- **Tập chải răng:** đây là lứa tuổi thích hợp để bắt đầu.
- **Không mớm (bón bằng miệng) thức ăn** cho trẻ: tránh lây **vi khuẩn gây sâu răng** từ người lớn sang trẻ.

Vì sao bú đêm lại hại răng đến vậy? Ban đêm trẻ nuốt ít, **nước bọt tiết ít** nên không rửa trôi được sữa. Đường đọng quanh răng suốt nhiều giờ là "bữa tiệc" cho vi khuẩn sinh acid → men răng sữa (vốn mỏng) bị phá hủy nhanh, nhiều răng cùng lúc.

- **Bệnh lý:**
  - Ăn đơn điệu → **biếng ăn, hạ đường huyết**, đói; ngược lại cha mẹ **ép ăn**, **lạm dụng thuốc bổ** cũng thường gặp.
  - Tiếp xúc xã hội rộng → dễ mắc **bệnh truyền nhiễm** (sởi, ho gà, bạch hầu, uốn ván, sốt xuất huyết, viêm gan siêu vi) nếu chưa tiêm đủ.
  - Hệ miễn dịch hoạt động mạnh → tăng **bệnh dị ứng, tự miễn**: viêm cầu thận cấp, hen suyễn, mề đay.
  - Tò mò, hiếu động → **tai nạn thương tích, ngộ độc** vẫn cao.
- **Phòng ngừa: muối iod** trong bữa ăn hằng ngày; tiêm chủng đủ; **khám răng định kỳ** (nha học đường); giáo dục phòng tai nạn; giảm mật độ muỗi.

5. THỜI KỲ THIẾU NHI

- **Thời gian: 7–11 tuổi** (tuổi học đường). Bước ngoặt lớn: hoạt động chủ đạo chuyển từ **vui chơi** sang **học tập**.
- **Sinh lý:**
  - Tách dần khỏi bố mẹ; lòng tự trọng hình thành qua kết quả học tập, năng khiếu; thường **chơi theo nhóm bạn cùng giới**.
  - Tiếp thu nhanh, biết phán đoán, tư duy phát triển; nhưng **cảm xúc chưa ổn định**, khó kiềm chế.

Thay răng vĩnh viễn

- Răng sữa rụng dần, thay bằng răng vĩnh viễn (tổng **32 răng**); thứ tự về cơ bản giống thứ tự mọc răng sữa.

Tuổi	Răng vĩnh viễn mọc
6–7 tuổi	4 răng hàm lớn thứ nhất (**răng số 6**, giữ khóa khớp cắn)
6–8 tuổi	4 răng cửa giữa
8–9 tuổi	4 răng cửa bên
9–10 tuổi	4 răng tiền hàm thứ nhất
12–14 tuổi	4 răng hàm lớn thứ hai
16–25 tuổi	4 răng hàm lớn thứ ba (răng khôn, răng cùng)

Lưu ý: bảng trên là các mốc bài giảng nêu (24 răng). 8 răng còn lại là **răng nanh** và **răng tiền hàm thứ hai** vĩnh viễn, thường mọc trong khoảng **10–12 tuổi**.

Cảnh báo thường gặp: răng số 6 mọc lúc 6 tuổi **không thay răng sữa nào**, mọc phía sau răng sữa cuối cùng. Phụ huynh hay **tưởng nhầm là răng sữa** nên bỏ mặc khi sâu – trong khi đây là răng **vĩnh viễn**, quan trọng bậc nhất cho khớp cắn.

- **Bệnh lý:**
  - **Răng vĩnh viễn mọc lệch:** răng sữa sâu tủy nặng không được điều trị hoặc nhổ đúng lúc → chân răng sữa nhiễm trùng **không tiêu** → cản trở răng vĩnh viễn, làm răng mọc lệch.
  - **Amidan phì đại:** amidan lúc này phát triển rất mạnh (**gấp đôi người lớn**). Phì đại quá mức → hẹp đường thở → **thở miệng kéo dài** → **biến dạng vòm họng, lệch lạc khớp cắn** (khớp cắn hở, hẹp xương hàm trên).
  - **Bệnh răng miệng học đường:** ở học sinh THCS chiếm **17,61%**.
  - Bệnh học đường khác: **tật khúc xạ**, bệnh ngoài da, giun sán, **vẹo cột sống** (dây chằng cột sống còn lỏng lẻo, dễ biến dạng nếu bàn ghế sai chuẩn).
  - Vẫn gặp **dị ứng** (hen) và **nhiễm trùng cấp** (viêm gan B, sốt xuất huyết, viêm màng não do não mô cầu).
  - Tâm lý: **nói lắp**, **sa sút học tập** (trí nhớ kém) → dễ tự ti, mặc cảm.
- **Phòng ngừa:** rèn thói quen vệ sinh cá nhân, học đường; **ánh sáng, bàn ghế đúng chuẩn nhân trắc** (tránh khúc xạ, vẹo cột sống); giáo dục sức khỏe răng miệng; giáo dục giới tính; phát hiện sớm rối loạn ngôn ngữ, hành vi.

Liên hệ nha khoa: trẻ **thở miệng, ngủ ngáy** không chỉ là chuyện tai mũi họng. Thở miệng kéo dài làm lưỡi hạ thấp, cung hàm trên hẹp lại, gây khớp cắn hở. Gặp trẻ hẹp hàm trên, khớp cắn hở → nhớ **hỏi về thở miệng và khám amidan**.

6. THỜI KỲ THIẾU NIÊN

- **Thời gian: 12–18 tuổi**, có thể kéo dài đến **20 tuổi** (tuổi vị thành niên).
- **Sinh lý:**
  - **Tuyến sinh dục hoạt động mạnh** → xáo trộn lớn về sinh học, nhận thức, tâm lý xã hội.
  - Não **không tăng nhiều về trọng lượng** nhưng hình thành nhanh các **vùng chuyên biệt** trên vỏ não (thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương).
  - **Dậy thì:** chuyển tiếp sinh học từ trẻ con sang người trưởng thành; đặc tính sinh dục thứ phát được đánh giá bằng thang **SMR (Sexual Maturity Rating)** hoặc **phân giai đoạn Tanner**.

- **Tăng trưởng vượt bậc:** chiều cao tăng vọt, đỉnh **8–9 cm/năm ở nữ**, **9–10 cm/năm ở nam**; cơ, mỡ dưới da, khối lượng máu thay đổi; nam vai rộng ngực nở, nữ mông và ngực phát triển.
- Nhu cầu năng lượng **rất cao: 80–150 kcal/kg/ngày**.
- **Trưởng thành sinh dục:** nữ có kinh nguyệt (có thể đau bụng kinh 1–2 năm đầu trước khi ổn định); nam mộng tinh (có tinh trùng khoảng 1 năm sau dậy thì), vỡ giọng, mọc râu.
- **Tâm lý:** tư duy trừu tượng phát triển; dễ kích động, cảm xúc thay đổi nhanh; muốn khẳng định mình là người lớn → dễ nổi loạn, phiêu lưu, tìm chất kích thích (thuốc lá, rượu, ma túy), lập băng nhóm, tò mò tình dục.

- **Bệnh lý:**
  - **Mọc răng khôn** (16–25 tuổi): **viêm lợi trùm**, răng **mọc ngầm, mọc lệch** gây xô lệch răng phía trước.
  - **Bệnh răng miệng học đường** vẫn cao: **14,01%** ở học sinh THPT.
  - **Thiếu vitamin C (scurvy)** biểu hiện ở nướu: nướu **tím xanh**, sưng, **rất dễ chảy máu**, nhất là vùng **răng cửa hàm trên**.
  - Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong **thấp nhất** trong các thời kỳ, nhưng trẻ **rất ngại đi khám**, nhập viện.
  - **Nhi xã hội:** có thai ngoài ý muốn, nghiện ngập, tự tử, bệnh lây qua đường tình dục.
  - Tâm lý lệch lạc: chống đối, **trầm cảm, lo âu** do áp lực học tập, xung đột gia đình, bạn bè.
- **Phòng ngừa:** phát triển dịch vụ **"Sức khỏe trẻ vị thành niên"**; giáo dục giới tính và tránh thai an toàn; cha mẹ làm **"người bạn lớn"**; tầm soát, can thiệp sớm trầm cảm, lo âu học đường.

> **Hiểu nhanh:** tuổi thiếu niên là lúc **cơ thể khỏe nhất** nhưng **rủi ro hành vi cao nhất**. Vấn đề sức khỏe chính không còn là nhiễm trùng mà là **tâm lý – xã hội**. Thầy thuốc cần **lắng nghe, tôn trọng sự riêng tư** thì các em mới chịu nói thật và quay lại khám.

7. BẢNG TỔNG HỢP BỆNH LÝ VÀ RĂNG MIỆNG THEO THỜI KỲ

Thời kỳ	Bệnh lý nổi bật	Điểm răng miệng
Bào thai	Dị tật bẩm sinh, sẩy thai, suy dinh dưỡng bào thai	Mầm răng sữa hình thành từ 3 tháng đầu
Sơ sinh	Tử vong cao nhất, sang chấn sản khoa, nhiễm trùng nặng	Phản xạ bú, sữa non
Nhũ nhi	Rối loạn tiêu hóa, SDD, sốt co giật, khoảng trống miễn dịch	Răng đầu tiên lúc 6 tháng, 8 răng cửa đến 12 tháng
Răng sữa	Biếng ăn, truyền nhiễm, dị ứng – tự miễn, tai nạn	Đủ 20 răng sữa lúc 30 tháng; sâu răng do bú đêm
Thiếu nhi	Bệnh học đường, amidan phì đại, vẹo cột sống	Thay răng; răng số 6 lúc 6–7 tuổi
Thiếu niên	Nhi xã hội, trầm cảm, lo âu	Răng khôn, viêm lợi trùm, scurvy ở nướu

> **Ghi nhớ cả bài:** 6 thời kỳ với các mốc **28 ngày – 1 tuổi – 6 tuổi – 11 tuổi – 18 tuổi**. Sơ sinh **tử vong cao nhất**, thiếu niên **thấp nhất**. Nhũ nhi lớn nhanh nhất và có **khoảng trống miễn dịch sau 6 tháng**. Răng sữa đủ **20 răng lúc 30 tháng**, răng vĩnh viễn đầu tiên là **răng số 6 lúc 6–7 tuổi**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Các thời kỳ tuổi trẻ.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.